

QCM 1. Les contre-indications à la paracentèse sont les suivantes sauf :

- A. Patients dont l'état général est altéré
- B. Abdomen chirurgical aigu
- C. Diathèse hémorragique
- D. Grossesse ou gros kystes ovariens
- E. Collections liquides columineuses qui provoquent des troubles hémodynamiques et respiratoires dus à la compression du diaphragme ou de la veine cave inférieure

QCM 2. Dans la définition de la constipation, le critère du nombre de selles hebdomadaires (selles par semaines) fait référence à :

- A. Une évacuation hebdomadaire ou moins
- B. Deux évacuations hebdomadaires ou moins
- C. Trois évacuation hebdomadaire ou moins
- D. Quatre évacuation hebdomadaire ou moins
- E. Moins d'une évacuation quotidienne

QCM 3. Les objectifs pour le traitement des escarres sont les suivants sauf :

- A. Contrôle de la douleur et de l'inconfort
- B. Augmentation de la mobilité articulaire et de la force musculaire
- C. Prévenir l'infection des escarres
- D. Contrôle des odeurs et des exsudats
- E. Réduction des saignements

QCM 4. L'irritation cutanée est le plus souvent causée par une fuite de matériel stomatique, les causes les plus fréquentes étant les suivantes sauf :

- A. Erythème
- B. Erosion
- C. Macération
- D. Dermatite de contact
- E. Tumeur maligne de la peau

QCM 5. Les techniques d'auto-soins et d'exercices pour le lymphœdème comprennent les suivantes :

- A. Bandage compressif
- B. Exercices isométriques
- C. Auto-massage de drainage lymphatique
- D. élévation du membre atteint
- E. Contrôle du poids corporel

QCM 6. Les examens d'imagerie pour le diagnostic positif et différentiel du lymphœdème comprennent les éléments suivants sauf,

- A. Echographie/ écho Doppler
- B. TDM
- C. IRM
- D. Lymphoscintigraphie
- E. Endoscopie veineuse

QCM 7. L'étiopathogénie du lymphœdème secondaire est représenté par les suivantes causes sauf

- A. Augmentation de l'apport en protéines
- B. Une intervention chirurgicale
- C. La radiothérapie
- D. Une néoplasie
- E. Une infection

QCM 8. La phase proliférative de la cicatrisation (escarre) est représentée par :

- A. Migration des leucocytes
- B. Enlèvement des tissus morts
- C. Infiltration de la plaie avec de nouveaux vaisseaux sanguins soutenus par du tissu conjonctif
- D. Réorganisation du tissu conjonctif
- E. La formation des phlyctènes

QCM 9. Selon le degré d'évolution des ulcères de décubitus, un patient présentant un érythème, une microcirculation altérée, des écorchures superficielles et des phlyctènes

- A. Stade 1
- B. Stade 2
- C. Stade 3
- D. Stade 4
- E. Stade 5

QCM 10. Les facteurs extrinsèques prédisposant aux ulcères de décubitus sont les suivants sauf

- A. Incontinence, transpiration
- B. Alitement prolongé
- C. Mauvaise hygiène (peau, literie)
- D. Antibiotiques
- E. L'humidité (pellicule plastique ou chiffon)

QCM 11. Il existe une susceptibilité au lymphœdème chez les patients atteints des néoplasmes sauf

- A. Les tumeurs de la tête et du cou
- B. Le tube digestif
- C. Sein
- D. Gynécologique
- E. Mélanome

QCM 12. Le traitement du lymphœdème clinique précoce repose sur

- A. Compression (manchon de compression)
- B. Traitement décongestionnant complet
- C. Thérapie pneumatique
- D. Chirurgie de drainage lymphatique
- E. Mise sous vide

QCM 13. En cas de lymphœdème, selon l'indice de gravité volumique, une augmentation de 15% est incluse comme

- A. Le lymphœdème est absent
- B. Lymphœdème minime

- C. Lymphœdème léger
- D. Lymphœdème modéré
- E. Lymphœdème sévère

QCM 14. Mesures de soins et de traitement pour les œdèmes légers

- A. Diurétiques (furosémide)
- B. Lifting (soulever le membre affecté)
- C. Pompe à compression pneumatique intermittente
- D. Réchauffement du membre affecté
- E. Endoprothèse veineuse

QCM 15. Parmi les mécanismes physiopathologiques de l'œdème figurent les suivants sauf

- A. Augmentation de la pression oncotique interstitielle
- B. Augmentation de la pression hydrostatique capillaire
- C. Diminution de la pression hydrostatique interstitielle
- D. Perméabilité capillaire accrue
- E. Faible apport en sodium

QCM 16. Les éléments suivants sont valables pour l'œdème périphérique

- A. Elle peut être causée par des compression ou une thrombose des artères
- B. Est défini comme une accumulation intravasculaire de liquide
- C. Représente une accumulation de liquide dans les tissus infusés par la circulation périphériques
- D. L'un des mécanismes physiopathologiques est une augmentation de la pression artérielle
- E. L'un des mécanismes physiopathologiques est la diminution de la pression oncotique interstitielle

QCM 17. Les éléments suivants peuvent être recommandés pour le traitement de la constipation

- A. Augmenter l'apport en fibres alimentaires
- B. Imodium
- C. Argiles protectrices
- D. Lactulose
- E. Traitement chirurgical- réservé à la constipation secondaire par obstruction

QCM 18. Médicaments pouvant causer de la constipation

- A. Préparations de calcium
- B. Bloqueurs de canaux calciques
- C. Préparations de fer
- D. Analgésiques opioïdes
- E. Bisacodyl

QCM 19. Maladies dans lesquelles se manifeste la constipation secondaire :

- A. Hyperthyroïdie
- B. Hypothyroïdie
- C. Hypercalcémie
- D. Hypocalcémie
- E. Tumeurs du côlon ou du rectum

QCM 20. Constipation habituelle

- A. Elle est moins fréquente que la constipation symptomatique (secondaire)
- B. C'est la forme la plus courante de constipation
- C. Il survient plus fréquemment chez les hommes
- D. Il survient plus fréquemment chez les femmes
- E. Elle est favorisée par les erreurs alimentaires

QCM 21. Pour définir la constipation, les éléments à considérer sont

- A. La durée de la symptomatologie est supérieure à 3 jours
- B. La durée de la symptomatologie est supérieure à 3 semaines
- C. La durée de la symptomatologie est supérieure à 3 mois
- D. Augmentation de la consistance des selles à plus de 25% des émissions
- E. Effort de défécation ou sensation d'évacuation incomplète à plus de 25% des émissions

QCM 22. Pour le traitement de la diarrhée on peut envisager

- A. Le bisacodil
- B. Sulfate de magnésium intraveineux
- C. Imodium
- D. Augmenter l'apport en fibres
- E. Argiles protectrices

QCM 23. Diarrhée chronique

- A. Il a une durée de manifestation de plus de 5-7 jours
- B. Il dure plus de 4 semaines
- C. L'évaluation du contexte épidémiologique indiquera l'agent causal dans la plupart des cas
- D. Elle doit être différenciée de l'incontinence fécale (élimination involontaire des matières fécales lorsque la consistance des selles est plus liquide)
- E. Il doit être traité avec des antibiotiques en association pendant 10 à 14 jours

QCM 24. Diarrhée aiguë (plus de 3 selles non formées en 24h)

- A. Il peut durer jusqu'à 3 jours
- B. Cela peut durer au maximum 2-3 semaines
- C. En cas de diarrhée infectieuse, la présence de sang et de leucocytes dans les selles est un signe de gravité
- D. En cas de diarrhée infectieuse, le contexte épidémiologique sera analysé
- E. En cas d'absence de signes de gravité, la réhydratation et l'antibiothérapie sont utilisées en association pendant 7 jours

QCM 25. La diarrhée sécrétoire survient

- A. Médicaments induits par les laxatifs (bisacodil)
- B. Induit par des composés organophosphorés
- C. Induit par des entérotoxines bactériennes (vibrio cholerae)
- D. Ingestion de sulfate de magnésium pour le suicide
- E. En cas de tumeurs productrices d'hormones

QCM 26. La diarrhée osmotique survient

- A. En raison d'un écoulement d'eau de la paroi intestinale dans la lumière, afin d'isotoniser le contenu intestinal
- B. Induit par des entérotoxines bactériennes (*vibrio cholerae*)
- C. Ingestion de champignons vénéneux
- D. En raison de l'ingestion de polyéthylène glycol, de sorbitol, mannitol, lactulose, sulfate de magnésium
- E. Cas de malabsorption du glucose- galactose ou fructose

QCM27. La définition du syndrome diarrhéique prend en compte

- A. Nombre de selles (nombre d'évacuations) par jour
- B. La consistance des selles
- C. Augmentation de la quantité de matière émise en 24 heures (augmentation du poids des selles)
- D. Effort de défécation à plus de 25% des émissions
- E. Sensation d'échappement incomplet à plus de 25% des émissions

QCM 28. Mesures utiles pour la prévention des escarres

- A. Hygiène générale, évaluation et traitement de l'incontinence, observation régulière des points de pression
- B. Réduction du cisaillement, de la pression (mobilisation passive toutes les 2 heures, utilisation de matelas spéciaux)
- C. Mobilisation des patients
- D. Contrôle de la douleur
- E. Antibiothérapie prophylactique

QCM 29. L'utilisation d'antiseptiques dans la plaie (escarre) doit tenir compte de leurs effets secondaires potentiels :

- A. Les solutions à base de chlore peuvent être toxiques pour les tissus granuleux, maintenir l'inflammation des plaies, irriter la peau saine
- B. Peroxyde d'hydrogène : détruit le tissu de granulation, macère une peau saine
- C. Le peroxyde d'hydrogène provoque des réactions allergiques
- D. Les solutions chlorées sont associées à un risque d'embolie
- E. La povidone iodée peut retarder la cicatrisation

QCM 30. Utilisation du lavage (irrigation) pour nettoyer les plaies (escarres)

- A. Elimine les micro-organismes de la plaie
- B. Enlève les corps étrangers de la plaie
- C. Il sera fait avec des fluides froids pour prévenir la douleur
- D. Cela se fera avec fluides à température corporelle
- E. Cela se fera avec des fluides chauffés à 45-47°C pour un effet antibactérien

QCM 31. Utilisation de tampons pour nettoyer les plaies (escarres)

- A. Elimine efficacement les bactéries de la plaie
- B. Au contraire, il redistribue les bactéries à la surface de la plaie
- C. Stimule la formation de tissu de granulation
- D. Peut causer un nouveau traumatisme, détruisant le tissu granuleux
- E. Il peut laisser de fines fibres dans la plaie qui maintiennent l'inflammation

QCM 32. Le principe de cicatrisation plus rapide des escarres en milieu humide attribue les actions suivantes à l'exsudat de la plaie

- A. Laver la plaie et la garder humide
- B. C'est un bon milieu de culture pour les bactéries, favorisant leur multiplication
- C. En raison de sa teneur en leucocytes, il combat les bactéries
- D. Fournit des conditions optimales pour la migration des cellules épithéliales et la mitose
- E. Il a une action thrombotique sur la microcirculation et limite les hémorragies

QCM 33. Facteurs qui retardent la cicatrisation des escarres

- A. Apport d'albumine
- B. Transfusion
- C. Corps étrangers dans la plaie
- D. Présence d'infection et de sécrétions purulentes
- E. Stéroïdes volumineux ou à action prolongée

QCM 34. Une escarre de grade 4 peut présenter

- A. Lésions limitées au tissu sous-cutané
- B. Affectant le fascia profond
- C. Dommages musculaires
- D. Les lésions peuvent atteindre l'os
- E. Fistules

QCM 35. Les facteurs intrinsèques de prédisposition aux ulcères de décubitus sont

- A. Déficit neurologique
- B. Epilepsie
- C. Cancer, diabète, septicémie
- D. Obésité, cachexie
- E. Sédation

QCM 36. Les escarres de décubitus

- A. Elles résultent de troubles de la circulation sanguine et lymphatique au niveau de la peau et des tissus sous-jacents
- B. Ils sont le résultat d'une exposition prolongée des extrémités à des températures inférieures à 20°C
- C. Le mécanisme de la circulation altérée est la compression et le cisaillement
- D. Le mécanisme de la circulation altérée est la vasoconstriction
- E. Le mécanisme de la circulation altérée est l'hypothermie locale

QCM 37. Lors du remplacement de la collerette du dispositif stomatique, vous devez

- A. Examinez la peau autour de la stomie à la recherche de rougeurs ou de dommages
- B. Examinez l'arrière de la bride (pour l'érosion ou le liquide stomatique)
- C. Le patient doit être allongé en décubitus dorsal (clinostatisme)
- D. Pour que le patient s'allonge sur le dos
- E. Pour que le patient soit couché sur le dos, orthostatique ou assis

QCM 38. Pour prévenir l'irritation de la peau dans les systèmes de l'estomac

- A. Les appareils seront changés régulièrement

- B. L'adhésif (bride) se décollera doucement
- C. L'adhésif (bride) se décollera en une manœuvre rapide
- D. Les appareils seront remplacés en cas de crevaisson ou de brûlure
- E. Il est recommandé de ne remplacer l'appareil qu'en cas de fuite

QCM 39. La bride du système gastrique

- A. Doit être appliqué sur peau sèche
- B. Doit être appliqué sur peau humide immédiatement après le lavage à l'eau et au savon
- C. Doit être appliqué sur la peau après application d'une crème antibiotique
- D. Doit être appliqué sur la peau après application d'une solution désinfectante
- E. Il doit être coupé pour s'adapter à la taille et à la forme de la stomie

QCM 40. Un bon adhésif du système stomatique doit répondre aux caractéristiques suivantes

- A. Avoir une emprise sur la peau
- B. N'absorbe pas le liquide sur la peau
- C. Ne soit pas irritant
- D. Être sans odeur et sans goût
- E. Être facile à enlever

QCM 41. Dans le cas des personnes ayant des stomates/systèmes stomatiques (colostomie, iléostomie)

- A. La pénétration de substances intestinales sous la collerette peut provoquer des fuites
- B. La plupart des irritations cutanées péristomiales sont dues à des réactions allergiques à l'adhésif
- C. La plupart des irritations cutanées sont dues à un écoulement de la stomie
- D. Initialement, le contenu de la stomie passe sous la collerette puis sur les vêtements
- E. L'éclatement des poches est la principale cause d'irritations cutanées

QCM 42. Pratiques pour réduire le risque de lymphœdème

- A. De préférence, la ponction veineuse sur le membre à risque de lymphœdème doit être évitée
- B. Les mesures de la pression artérielle sur le membre à risque de lymphœdème doivent être évitées
- C. Utilisation de l'aspirateur pendant le vol sur le membre à risque de lymphœdème
- D. Port de gants ou de bandages compressifs dans l'avion sur le membre à risque de lymphœdème
- E. Application quotidienne de crèmes stéroïdiennes et éviter les bains sur le membre à risque de lymphœdème

QCM 43. Une susceptibilité accrue au lymphœdème survient chez les patients atteints de néoplasmes

- A. Bronchopulmonaire
- B. Tube digestif
- C. Sein
- D. Gynécologique
- E. Mélanome

QCM 44. La prévention du lymphœdème chez les personnes à risque comprend les indications suivantes

- A. S'abstenir de tout exercice
- B. Exercices spécifiques prescrits individuellement
- C. Eviter l'obésité qui est un facteur de risque de lymphœdème secondaire
- D. Evitement total de l'exposition au soleil
- E. Crèmes anti-inflammatoires

QCM 45. Les examens de laboratoire pour le diagnostic positif et différentiel du lymphœdème comprennent

- A. La fonction thyroïdienne
- B. Spirométrie
- C. Examen doppler carotidien
- D. La fonction hépatique
- E. La fonction rénale

QCM 46. Stadification du lymphœdème selon la fibrose tissulaire (stade 0 à 3) les éléments suivants sont corrects

- A. Stade 0 : subclinique (latente), avec le potentiel de devenir cliniquement évident
- B. Stade 1 : signe du godet positif, dépôts fibrogras sous-cutanés, distorsion architecturale, lymphœdème irréversible en, élévation
- C. Stade 2 : signe du godet positif et réversible en élévation
- D. Stade 3 : excroissances dermiques verruqueuses, distorsion architecturale sévère
- E. Stade 3 : signe du godet négatif en raison de l'induration

QCM 47. Les mesures pour traitement de l'œdème comprennent

- A. Application diurétiques locaux
- B. Mouvement du membre affecté
- C. Elévation de la partie affectée
- D. Massage ferme, en particulier dans les thrombophlébites profondes
- E. Réduction de la consommation de sel

QCM 48. Enquêtes utiles dans l'évaluation des œdèmes

- A. Capillaroscopie
- B. Capillarographie
- C. Echographie Doppler veineuse
- D. Examen sommaire des urines
- E. IRM (résonance magnétique nucléaire)

QCM 49. Les maladies associées à une diminution de la pression oncotique plasmatique sont

- A. Régime hyposodique
- B. Malnutrition
- C. Thrombose veineuse profonde
- D. Le syndrome néphrotique
- E. Insuffisance hépatique

QCM 50. Parmi les mécanismes physiopathologiques de l'œdème figurent

- A. Diminution de la pression oncotique plasmatique
- B. Diminution de la pression oncotique interstitielle

- C. Augmentation de la pression oncotique plasmatique
- D. Augmentation de la pression oncotique interstitielle
- E. Diminution de la perméabilité capillaire